

TEMA 7.7 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Trastornos del Ánimo: Antidepresivos

PERFIL EUNACOM 1.09.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El tratamiento farmacológico de la depresión es un pilar fundamental en el manejo de los **Trastornos del Ánimo**. Para el médico general, es vital conocer no solo las familias de fármacos, sino también sus perfiles de efectos adversos, tiempos de latencia y manejo en poblaciones especiales.

Clasificación de los Antidepresivos

Los antidepresivos se agrupan según su mecanismo de acción sobre los neurotransmisores (serotonina, noradrenalina y dopamina).

TABLA 7.7.1: FAMILIA VS FÁRMACOS PRINCIPALES

FAMILIA	FÁRMACOS PRINCIPALES	INDICACIÓN DE PRIMERA LÍNEA
ISRS	Fluoxetina, Sertralina, Paroxetina, Citalopram, Escitalopram	Depresión mayor, ansiedad, TOC.
Duales (Noveles)	Venlafaxina, Duloxetina, Mirtazapina, Bupropión	Depresión resistente a ISRS.
Tricíclicos (ATC)	Amitriptilina, Nortriptilina, Imipramina, Clomipramina	Dolor crónico, neuropatías (uso limitado en depresión).
IMAO	Fenelzina, Selegilina, Moclobemida	Depresión atípica.

1. Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS)

Son los fármacos de **primera elección** en la mayoría de los cuadros depresivos debido a su perfil de seguridad y menor tasa de efectos adversos comparado con familias antiguas.

- **Fármacos destacados:**
 - **Fluoxetina:** El más antiguo de la familia.
 - **Sertralina:** De los más seguros, muy utilizado actualmente.
 - **Citalopram y Escitalopram:** Modernos y con alta frecuencia de uso.
 - **Paroxetina.**
- **Efectos Adversos:**
 - **Náuseas:** El efecto más frecuente, especialmente al inicio.
 - **Disfunción sexual:** Afectan tanto la **libido** (deseo) como la **potencia** (lograr/mantener la erección).

NOTA CLÍNICA

Patofisiología del efecto: Los ISRS aumentan la disponibilidad de serotonina en la hendidura sináptica. El inicio de acción clínico no es inmediato debido a que requiere una regulación a la baja (down-regulation) de los receptores postsinápticos, proceso que toma semanas.

2. Antidepresivos Duales o Noveles

Actúan sobre dos neurotransmisores simultáneamente (ej. Serotonina + Noradrenalina). Se indican principalmente cuando hay **falta de respuesta a los ISRS**.

- **Venlafaxina y Duloxetina:** Son los más comunes en esta categoría.
- **Bupropión:** Actúa sobre dopamina y noradrenalina.
- **Mirtazapina:** Destaca por su perfil de efectos secundarios.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: La **Mirtazapina** suele **NO** producir alteración sexual. Es una excelente alternativa para pacientes que suspenden ISRS por efectos adversos en la **libido** o **potencia**. (Mnemotecnia: "La señora Mirta no tiene problemas sexuales").

3. Antidepresivos Tricíclicos (ATC)

Fármacos antiguos con un estrecho margen terapéutico y múltiples efectos adversos, lo que limita su uso en dosis antidepresivas.

- **Efectos Adversos Graves:**
 - **Cardiotoxicidad:** Riesgo de **arritmias** (taquicardia ventricular) y prolongación del intervalo QT. Son potencialmente letales en sobredosis.
 - **Efectos Anticolinérgicos:** Boca seca, constipación, visión borrosa, **retención urinaria aguda** y descompensación de glaucoma.
 - **Efectos Antihistamínicos (H1):** Sedación marcada y **aumento de peso**.
- **Usos actuales (Dosis bajas):**
 - Manejo del **dolor crónico** y dolor neuropático.
 - Profilaxis de migraña (jaqueca) y cefalea tensional.
 - **Síndrome de Intestino Irritable con predominio de diarrea** (por su efecto secundario de constipación).

4. Inhibidores de la Monoaminoxidasa (IMAO)

Presentan efectos adversos importantes relacionados con el control de la presión arterial (hipertensión o hipotensión ortostática), taquicardia y síntomas anticolinérgicos.

- **Fármaco clave:** **Fenelzina.**
- **Indicación clásica:** Es el fármaco de elección para la **Depresión Atípica** (aquella con reactividad del ánimo, hipersomnia y aumento de apetito).

Manejo Clínico y Administración

El éxito del tratamiento depende de una buena educación al paciente sobre las expectativas del fármaco.

Inicio y Latencia

1. Inicio lento: Se debe comenzar con dosis bajas para evitar la inducción de síntomas ansiosos, insomnio o crisis de pánico. **2.**

Latencia de respuesta: El efecto antidepresivo demora entre **2 a 4 semanas**. Si el paciente no siente mejoría antes de este plazo, es normal y se debe incentivar la adherencia.

Mantención y Suspensión

- Una vez que los síntomas remiten por completo, el tratamiento debe mantenerse por **al menos 6 meses adicionales** para prevenir recaídas. - **Suspensión gradual:** Nunca suspender de forma brusca.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La suspensión súbita de ISRS puede provocar un **Síndrome de Discontinuación**, caracterizado por síntomas "flu-like" (similares a la gripe), cefalea, mareos y ansiedad.

Poblaciones Especiales

El perfil del paciente determina la elección del fármaco:

- **Adulto Mayor:**
 - **Elección:** ISRS (**Sertralina, Citalopram o Escitalopram**). Estos tres tienen menos interacciones medicamentosas.
 - **Contraindicados:** Tricíclicos (alto riesgo de arritmias, caídas y confusión).
- **Embarazo y Lactancia:**
 - **Elección:** **Sertralina**. Es segura en el embarazo y tiene un paso mínimo a la leche materna durante la lactancia. La Fluoxetina es una alternativa con muchos estudios, pero se prefiere Sertralina para evitar cambios de fármaco al nacer el niño.

- **Niños:** Se prefiere evitar fármacos e iniciar con **psicoterapia** como primera línea.
- **Paciente Cardiópata:** Evitar tricíclicos y paroxetina; preferir Sertralina o Citalopram.

El Riesgo de Viraje en el Trastorno Bipolar

Es fundamental descartar un **Trastorno Bipolar** antes de iniciar antidepresivos.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Los antidepresivos están **contraindicados en monoterapia** para la depresión bipolar. Existe un alto riesgo de **viraje a la manía** (el paciente se vuelve excesivamente eufórico, hiperactivo e impulsivo).

- **Conducta ante sospecha de viraje:**
- Suspender inmediatamente el antidepresivo.
- Derivar a psiquiatría para inicio de **estabilizadores del ánimo** (Litio, Ácido Valproico o Lamotrigina).
- **Temas relacionados:**
- **Depresión: Diagnóstico y Criterios**
- **Trastorno Bipolar**
- **Manejo de Intoxicaciones por Fármacos**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 72 años con diagnóstico de depresión mayor y cardiopatía hipertensiva. El médico decide iniciar antidepresivo. ¿Cuál es el fármaco más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos del Ánimo: Antidepresivos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- ISRS son de primera línea en depresión; el más seguro en adulto mayor, embarazo y lactancia es la sertralina.
- Los tricíclicos están contraindicados en adulto mayor y cardiopatías por riesgo de arritmias graves (taquicardia ventricular).
- La mirtazapina es un antidepresivo dual sin disfunción sexual; útil cuando hay efectos adversos sexuales con ISRS.
- Los ISRS deben iniciarse a dosis baja y suspenderse gradualmente; la discontinuación brusca causa síndrome flu-like más ansiedad.
- El efecto antidepresivo de los ISRS demora 2-4 semanas; se mantienen 6 meses más tras la remisión.
- Los antidepresivos están absolutamente contraindicados en trastorno bipolar porque pueden virar a manía.
- Los IMAOs (fenelzina) son de elección en depresión atípica (hipersomnia, aumento de peso, craving por dulces).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS DEL ÁNIMO: ANTIDEPRESIVOS)**PREGUNTA 1**

Mujer de 72 años con diagnóstico de depresión mayor y cardiopatía hipertensiva. El médico decide iniciar antidepresivo. ¿Cuál es el fármaco más adecuado?

- A)** Amitriptilina 75 mg/día
- B)** Fluoxetina 20 mg/día
- C)** Sertralina 50 mg/día
- D)** Fenelzina 15 mg/día
- E)** Paroxetina 20 mg/día

PREGUNTA 2

Paciente de 35 años inicia tratamiento con fluoxetina 20 mg/día por depresión mayor. A los 15 días consulta porque "está igual de mal que antes, sigue muy deprimido". No presenta efectos adversos. ¿Cuál es la conducta correcta?

- A)** Cambiar a venlafaxina por falla terapéutica
- B)** Suspender fluoxetina y esperar
- C)** Educar al paciente: los ISRS demoran 2-4 semanas en hacer efecto; continuar con el mismo fármaco
- D)** Agregar benzodiacepina para refuerzo antidepresivo
- E)** Doblar la dosis de fluoxetina

PREGUNTA 3

Paciente de 28 años está siendo tratado por un primer episodio depresivo con sertralina 50 mg/día. A las 6 semanas refiere sentirse "perfectamente bien, lleno de energía, no necesita dormir, tiene muchas ideas y proyectos". Su esposa llama preocupada porque gastó toda la cuenta bancaria en inversiones en 2 días. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Aumentar la dosis de sertralina porque el paciente refiere bienestar
- B)** Suspender sertralina y derivar a psiquiatría por sospecha de trastorno bipolar
- C)** Interpretar como recuperación completa de la depresión y suspender gradualmente
- D)** Agregar haloperidol para control de la agitación
- E)** Tranquilizar a la esposa; es efecto secundario esperado del antidepresivo

RESUMEN: TRASTORNOS DEL ÁNIMO: ANTIDEPRESIVOS

Los antidepresivos se clasifican en cuatro familias principales. Los ISRS (inhibidores de la recaptura de serotonina) son los de primera línea para la mayoría de las depresiones por tener menor perfil de efectos adversos. Los más importantes son fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram y escitalopram. Sus efectos adversos más frecuentes son náuseas y disfunción sexual (impotencia y disminución de la libido). Los antidepresivos duales (también llamados noveles o ISRN) actúan sobre dos neurotransmisores: venlafaxina, duloxetina, mirtazapina y bupropión. Son de elección cuando el ISRS falla o no es tolerado; la mirtazapina no produce disfunción sexual. Los IMAOs (fenelzina, selegilina, moclobemida) son de elección en la depresión atípica, pero tienen múltiples efectos adversos (hiper e hipotensión, síntomas anticolinérgicos). Los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina, imipramina, clomipramina) tienen efectos anticolinérgicos (constipación, retención urinaria, boca seca, glaucoma), antihistamínicos (sedación, aumento de peso) y arritmias graves; no se usan actualmente para depresión, pero sí en dosis bajas para dolor crónico, neuralgia, cefalea tensional e intestino irritable con diarrea. La administración de ISRS requiere inicio gradual (dosis baja, incrementar paulatinamente) para evitar síntomas ansiosos iniciales. El efecto antidepresivo demora 2-4 semanas en aparecer. Tras la remisión se mantienen por al menos 6 meses más, luego se suspenden gradualmente para evitar el síndrome de discontinuación (síntomas ansiosos + síndrome flu-like). En poblaciones especiales: adulto mayor usa sertralina/citalopram (nunca tricíclicos); embarazo y lactancia: sertralina (no cruza leche materna); niños: preferir psicoterapia sin fármacos; trastorno bipolar: antidepresivos absolutamente contraindicados (pueden virar a manía).